Carte 01

Comment situer le système de soins dans le système de santé ?

Carte 02

Quels grands objectifs retenir pour le système de santé ?

Carte 03

Pourquoi une offre identique ne garantit-elle pas un accès équitable ?

Carte 04

Quelles professions constituent le groupe des professions médicales ?

Carte 05

À quoi sert un ordre professionnel ?

Carte 06

Que signifie un exercice professionnel mixte ?

Carte 02

Améliorer la santé, répondre aux attentes de la population et assurer l'équité. Accès, qualité, sécurité et continuité contribuent à ces objectifs.

Carte 01

Le système de soins est une partie du système de santé, qui inclut aussi pilotage, financement, prévention, information et recherche. La santé mobilise des actions au-delà des consultations et des traitements.

Carte 04

Médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. La classification des professions ne suffit pas à déterminer tous les actes autorisés.

Carte 03

Les possibilités de déplacement, les délais et les besoins peuvent différer malgré une offre apparemment identique. L'accès doit être apprécié à partir des possibilités concrètes des personnes.

Carte 06

Une même personne combine une activité salariée et une activité libérale. Le lieu de travail ne suffit pas à identifier le statut professionnel.

Carte 05

Il contribue à la régulation de l'exercice, à la tenue du tableau, à la déontologie et à la discipline de sa profession. Il se distingue d'un employeur et d'un organisme de remboursement.

Carte 07

Quelle différence entre effectif et densité ?

Carte 08

Pourquoi une projection n’est-elle pas une observation ?

Carte 09

Comment passer de la présence de professionnels à l’analyse de l’accès ?

Carte 10

Quels sont les trois grands ensembles de lieux de soins ?

Carte 11

Pourquoi le statut juridique ne décrit-il pas toute l’activité d’un établissement ?

Carte 12

Comment distinguer MCO, réadaptation et USLD ?

Carte 08

Une projection décrit un avenir possible fondé sur des hypothèses ; une observation porte sur des données recueillies. La date, le territoire, la profession et le type de mesure doivent accompagner la lecture.

Carte 07

L'effectif est un nombre de professionnels ; la densité rapporte ce nombre à une population, selon une unité précisée. Une comparaison exige un même champ, une même profession et une unité cohérente.

Carte 10

Établissements de santé, structures médico-sociales et soins de ville. Ces catégories décrivent des organisations et non des niveaux de gravité.

Carte 09

Examiner les délais, la disponibilité, les déplacements, la coordination et la compréhension des démarches. Une ressource présente sur une carte peut rester difficile à mobiliser.

Carte 12

MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; réadaptation : récupération et adaptation ; USLD : surveillance médicale importante et durable. Ces finalités se distinguent du statut public ou privé de la structure.

Carte 11

Il renseigne une catégorie d'organisation, mais ne suffit pas à connaître toutes les activités, autorisations ou missions. Il faut distinguer public, privé non lucratif et privé lucratif sans déduire une activité du seul statut.

Carte 13

Un soin à l'hôpital implique-t-il une nuitée ?

Carte 14

Tout soin infirmier au domicile est-il une HAD ?

Carte 15

Que faut-il préparer avant un retour à domicile ?

Carte 16

Un soin non programmé est-il toujours une urgence vitale ?

Carte 17

À quoi sert le SAS dans le parcours présenté ?

Carte 18

Quelle distinction faire avant d'orienter une demande imprévue ?

Carte 14

Non. L'HAD est une organisation hospitalière au domicile ; une intervention de ville à domicile n'en est pas automatiquement une. L'adresse du soin ne suffit pas à identifier son organisation.

Carte 13

Non. Consultation, examen ou hôpital de jour peuvent se dérouler à l'hôpital sans nuitée. Le lieu hospitalier ne suffit pas à caractériser une hospitalisation conventionnelle.

Carte 16

Non. Le besoin appelle une réponse rapide, mais son caractère imprévu ne définit pas à lui seul sa gravité. Programmation et degré d'urgence décrivent deux dimensions différentes.

Carte 15

Les soins prévus, les relais professionnels, les informations utiles et les conditions de vie au domicile. Le développement de l'ambulatoire suppose une organisation adaptée, et non la seule décision de sortie.

Carte 18

Distinguer besoin non programmé et urgence vitale, puis rechercher une orientation adaptée. L'indisponibilité du médecin ne suffit pas à définir la gravité de la situation.

Carte 17

Le service d'accès aux soins participe à la régulation et à l'orientation vers une réponse adaptée aux ressources du territoire. Il ne garantit pas automatiquement un rendez-vous dans un délai identique pour tous.

Carte 19

Quel est le rôle du premier recours ?

Carte 20

Une consultation spécialisée en ville peut-elle être de deuxième recours ?

Carte 21

Les niveaux spécialisés sont-ils des étapes obligatoires pour tous ?

Carte 22

Quel rôle central joue le médecin traitant ?

Carte 23

Pourquoi le compte rendu doit-il revenir vers le médecin traitant ?

Carte 24

Pourquoi ne pas résumer le parcours coordonné à un taux unique ?

Carte 20

Oui. Le niveau de recours dépend de l'expertise et des ressources nécessaires, pas seulement du bâtiment. Un CHU peut aussi réaliser des soins qui ne sont pas de haute spécialisation.

Carte 19

Assurer un premier contact, répondre aux besoins courants, prévenir et suivre au plus près de la population. Il mobilise plusieurs professions et ne constitue pas un soin de moindre valeur.

Carte 22

Soins, prévention personnalisée, orientation, coordination et suivi. Cette fonction peut être exercée par un généraliste ou un spécialiste, en ville ou à l'hôpital.

Carte 21

Non. L'orientation dépend du besoin de moyens ou d'expertise ; chaque personne ne passe pas par tous les niveaux. Les prises en charge complexes ou particulièrement spécialisées répondent à des situations spécifiques.

Carte 24

Il organise la cohérence des soins ; les règles précises de prise en charge dépendent de la situation et du cadre applicable. Des accès directs et des situations particulières existent sans annuler l'objectif de continuité.

Carte 23

Il permet de comprendre la décision, d'ajuster le suivi et d'articuler les interventions. L'aller vers un spécialiste sans retour d'information peut laisser les soins juxtaposés.

Carte 25

Que comprend le parcours de santé en plus du parcours de soins ?

Carte 26

Comment élargir un retour à domicile au-delà du soin technique ?

Carte 27

Quel intérêt a une coordination territoriale face à la chaleur ?

Carte 28

Pourquoi la proximité géographique ne suffit-elle pas à coordonner ?

Carte 29

Quelle différence entre MSP et CPTS ?

Carte 30

Quels besoins une CPTS peut-elle aider à organiser ?

Carte 26

Organiser le soin prévu et explorer les besoins d'aide, les ressources et les déplacements avec la personne. Les dimensions de soins, d'autonomie et de vie quotidienne doivent être reliées.

Carte 25

Les dimensions médico-sociales et sociales, dont autonomie, ressources, déplacements et accès aux droits. Le raisonnement porte sur la personne dans son milieu de vie.

Carte 28

La coordination exige des objectifs communs, des liens et des modalités de coopération. Des professionnels voisins peuvent continuer à intervenir sans articuler leurs décisions.

Carte 27

Relier les besoins des habitants, la surveillance et les ressources locales pour adapter les réponses. Cet exemple illustre une articulation ; il ne constitue pas un protocole unique pour toutes les situations.

Carte 30

Accès aux soins, parcours complexes, prévention, crises sanitaires, accompagnement des professionnels et qualité des soins. Ces missions visent les besoins du territoire et le décloisonnement des acteurs.

Carte 29

La MSP est une organisation de soins pluriprofessionnelle ; la CPTS coordonne des acteurs à l'échelle d'un territoire. Une CPTS dépasse une seule structure et peut relier ville, établissements et médico-social.

Carte 31

Quel objectif relie DMP et Mon espace santé à la coordination ?

Carte 32

Une messagerie sécurisée autorise-t-elle toute transmission ?

Carte 33

Pourquoi distinguer accès technique et partage approprié ?

Carte 34

Comment distinguer Parlement, ministère et ARS ?

Carte 35

Quelle distinction retenir entre déconcentration et décentralisation ?

Carte 36

Pourquoi adapter une politique nationale au territoire ?

Carte 32

Non. Il faut vérifier le destinataire, l'utilité pour la prise en charge et le cadre de confidentialité. La protection du canal ne justifie pas un partage sans limite.

Carte 31

Faciliter la disponibilité et la circulation des informations utiles au suivi. Un outil numérique soutient la continuité, sans remplacer le dialogue ni le raisonnement professionnel.

Carte 34

Le Parlement vote les lois ; le ministère conduit les politiques nationales ; l'ARS les met en œuvre et les adapte au niveau régional. Les réponses concrètes mobilisent aussi les acteurs du territoire.

Carte 33

Un document accessible n'est pas automatiquement utile à tout destinataire ni à diffuser sans limite. La coordination exige un choix d'informations pertinentes et un échange adapté.

Carte 36

Les besoins et les ressources régionaux diffèrent ; la mise en œuvre doit en tenir compte. Un cadre commun n'impose pas une copie uniforme de chaque réponse locale.

Carte 35

La déconcentration décrit un déploiement territorial du pilotage national ; la décentralisation renvoie à une autre répartition des compétences. Cette distinction ne réduit pas toute l'organisation sanitaire à une chaîne unique.

Carte 37

Quels grands apports relier à 1945 et 1958 ?

Carte 38

Quels apports relier à 2002 et à la loi HPST de 2009 ?

Carte 39

Une loi générale de santé est-elle automatiquement votée tous les cinq ans ?

Carte 40

Comment distinguer DGS, DGOS et DSS ?

Carte 41

Quels rôles associer à DREES, DGCS et IGAS ?

Carte 42

Quels quatre domaines retenir pour les ARS ?

Carte 38

2002 renforce la place et les droits des patients ; 2009 est un repère d'organisation territoriale, notamment autour des ARS et des ESPIC. Il faut comprendre les apports sans transformer une chronologie en garantie de contenu d'examen.

Carte 37

1945 : construction de la Sécurité sociale ; 1958 : réforme hospitalo-universitaire et création des CHU. Les repères historiques servent à comprendre les évolutions et leurs fonctions.

Carte 40

DGS : santé publique ; DGOS : offre de soins ; DSS : protection sociale et cadre financier. Les sigles proches renvoient à des fonctions distinctes.

Carte 39

Non. Il faut distinguer les évolutions législatives de santé et la LFSS annuelle, qui fixe notamment un cadre et des objectifs financiers. Une périodicité évoquée dans un support ne devient pas une règle automatique.

Carte 42

Offre de soins, accompagnement médico-social, prévention et promotion, veille et sécurité sanitaire. Ces domaines permettent d'articuler organisation et protection de la santé dans la région.

Carte 41

DREES : études et statistiques ; DGCS : cohésion sociale ; IGAS : inspection des affaires sociales. Partir de la fonction permet d'éviter la confusion entre organismes aux sigles proches.

Carte 43

Comment situer OMS, ECDC et ARS ?

Carte 44

Quels exemples relient la santé au niveau européen ?

Carte 45

Directive et règlement sont-ils deux noms d'un même instrument ?

Carte 46

Quelles missions retenir pour la HAS ?

Carte 47

Comment distinguer qualité de réalisation et pertinence ?

Carte 48

Pourquoi l'efficience ne se réduit-elle pas au prix le plus bas ?

Carte 44

Les avertissements sanitaires sur le tabac et la protection des données personnelles, dont les données de santé. Ces exemples montrent que certaines règles dépassent l'échelon national.

Carte 43

OMS : mondiale ; ECDC : européenne ; ARS : régionale. L'échelle d'intervention et la fonction doivent être identifiées ensemble.

Carte 46

Expertise scientifique, évaluation, recommandations de bonne pratique, certification et amélioration de la qualité et de la sécurité. La Haute Autorité de santé se distingue du ministère et d'une caisse de remboursement.

Carte 45

Non. Il faut les distinguer et ne pas leur appliquer automatiquement une procédure unique. La distinction entre ces instruments ne décrit pas à elle seule toute la hiérarchie des normes.

Carte 48

Elle met en relation les résultats obtenus avec les ressources mobilisées. Réduire une dépense sans considérer les résultats ne suffit pas à démontrer une amélioration.

Carte 47

La qualité concerne la réalisation du soin ; la pertinence concerne son utilité et son adaptation au besoin. Un acte bien réalisé peut rester inapproprié dans une situation donnée.

Carte 49

L’Assurance maladie est-elle synonyme de toute la Sécurité sociale ?

Carte 50

Que désignent LFSS et ONDAM ?

Carte 51

Comment distinguer CNAM et CPAM ?

Carte 52

Pourquoi préciser le niveau de prise en charge avant de parler de reste à charge ?

Carte 53

Complémentaire santé et mutuelle sont-elles synonymes ?

Carte 54

L’absence d’avance des frais prouve-t-elle une couverture intégrale ?

Carte 50

La LFSS est la loi de financement de la Sécurité sociale ; l'ONDAM est l'objectif national de dépenses d'Assurance maladie. Ce sont des éléments du cadre financier, pas des organismes de remboursement.

Carte 49

Non. Elle est une composante d'une protection sociale couvrant plusieurs risques de la vie. La partie ne doit pas être confondue avec l'ensemble.

Carte 52

La somme restant après l'Assurance maladie peut différer de celle restant après une complémentaire. Le calcul dépend du niveau considéré et de la couverture applicable.

Carte 51

La CNAM pilote au niveau national ; les CPAM accompagnent les assurés et mettent en œuvre localement la gestion des droits et prestations. Une direction ministérielle, une caisse nationale et une caisse locale sont trois acteurs distincts.

Carte 54

Non. Modalité de paiement et niveau de remboursement doivent être distingués. Un obstacle financier appelle une orientation adaptée, sans promesse de gratuité fondée sur un exemple général.

Carte 53

La complémentaire désigne une couverture ; la mutuelle est un type d'organisme pouvant la proposer. Toutes les complémentaires ne sont pas des mutuelles.

Carte 55

Quel est l'objectif de la surveillance sanitaire ?

Carte 56

Comment distinguer pharmacovigilance, matériovigilance et hémovigilance ?

Carte 57

Pourquoi surveiller un médicament après sa mise à disposition ?

Carte 58

Quelles grandes familles d'acteurs mobilise la recherche en santé ?

Carte 59

Quelles trois missions sont articulées dans un CHU ?

Carte 60

Quelles trois questions aident à situer un acteur du système de santé ?

Carte 56

Pharmacovigilance : médicaments ; matériovigilance : dispositifs médicaux ; hémovigilance : chaîne transfusionnelle et produits sanguins concernés. Le type de produit ou d'activité oriente la vigilance pertinente.

Carte 55

Recueillir et analyser des informations pour suivre l'état de santé et les risques, repérer des signaux et éclairer la réponse. Surveiller ne se limite pas à compter ; l'information doit soutenir prévention et action.

Carte 58

CHU et universités, organismes ou instituts de recherche et laboratoires pharmaceutiques. Leurs activités de recherche s'articulent avec d'autres fonctions sans s'y confondre.

Carte 57

Des effets rares peuvent être repérés plus tard ; la surveillance complète l'évaluation initiale. Une utilisation ancienne ne démontre pas l'absence de tout risque.

Carte 60

À quelle échelle intervient-il, quelle fonction remplit-il et avec quels acteurs s'articule-t-il ? Cette méthode relie la situation aux ressources adaptées sans confondre coordination, financement et expertise.

Carte 59

Soin, enseignement et recherche. Ces missions sont reliées mais ne sont pas trois noms pour le même acte.